

Protocolo Clínico	Código: PCL.AS.CEGISS.AH.001
Assistência à Saúde	Versão: 003
Centro de Gestão Integrada dos Serviços de Saúde	Data da Emissão: 22/01/2024
Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar	Vencimento: 2 anos após a emissão

PROTOCOLO DE SEPSE

Histórico de Versões
001 - Emissão inicial
002 - Atualizadas as terminologias de sepse e condutas
003 - Atualização de conteúdo frente a boas práticas e evidências científicas recentes e referências

Fase	Nome	Setor/Unid.	Data	Documento
Elaboração	Luciane Picinato da Silva	Gestão da Informação	07/08/203	COREN - 79372
	Lara Balestra	CEGISS – Hospitalar	07/08/203	CREFITO-3 131468-F
	Lucilene de Fátima Rocha Cova	CEGISS – Hospitalar	07/08/203	COREN - 52867
	Susan Lopes Mizugai	CEGISS – Hospitalar	07/08/203	COREN - 228736
Análise	André Luis C Ramalho	CEGISS Pesquisa e Inovação Aplicada	22/01/2024	CRM-SP 116.483
	Rodolfo Bandeira	CEGISS Atenção Especializada	22/01/2024	CRM-SP 152.535
	Pâmela Lóia	SCIRAS CEGISS	22/01/2024	COREN-SP 203.704
	Rebecca Saad	SCIRAS CEGISS	22/01/2024	CRM-SP 111.092
Aprovação	Renato Tardelli Pereira	Diretoria Técnica	22/01/2024	CRM-SP 53.465

1. OBJETIVO

Primário:

- Reduzir a mortalidade dos pacientes decorrentes de Sepses;
- Garantir a identificação precoce da sepsis na instituição, com tratamento e monitoramento adequados;
- Coletar imediatamente o pacote/ kit Sepsis (Hemocultura 02 sítios (02 pares), hemograma completo, creatinina, ureia, sódio, potássio, gasometria (opcionalmente arterial, só necessário para paciente com insuficiência respiratória ou choque), lactato (para triagem em paciente sem enfermidade respiratória ou choque, pode ser venoso), glicemia, coagulograma, bilirrubinas, Raio X Tórax (suspeita de Pneumonia) e culturas adicionais (de outros sítios pertinentes).
- Administração de antimicrobiano em até uma hora após o reconhecimento de sinais da sepsis e após a coleta de exames.
- Administrar 30ml/kg de cristalóide (preferencialmente Ringer lactato) de 30 a 60 min se hipotensão (PAS<90mmHg ou PAM<65 mmHg) ou sinais de hipoperfusão (lactato > 2 vezes o valor de referência, tempo de enchimento capilar (maior) que 3s, e livedo e ou oligúria). Iniciar Noradrenalina (se hipotensão ameaçadora à vida ou hipotensão persistente);
- Garantir a realização da prática da melhor evidência científica com relação à abordagem inicial da sepsis.

Secundário:

- Orientar profissionais de saúde quanto aos sinais de alerta de sepsis e de disfunção orgânica associada a sepsis;
- Empoderar os profissionais para abertura do protocolo;
- Garantir a rápida internação do paciente com sepsis, após a sua identificação e abordagem inicial, em local apropriado na instituição (área crítica);
- Garantir a coleta de exames microbiológicos antes da administração do antimicrobiano, sem, contudo, determinar atrasos;
- Assegurar que a investigação da causa da sepsis, além de outros exames subsidiários (por exemplo: outras culturas e realização de exames de imagem) não levarão a atrasos na administração do antimicrobiano;
- Aumentar a identificação e abordagem da sepsis, conforme recomendações do Instituto Latino-Americano de Sepsis (ILAS);

- Garantir que os médicos do corpo clínico, responsáveis pelos pacientes, sejam devidamente informados que seu paciente foi incluído no protocolo institucional gerenciado de sepse, sem, contudo, gerar atrasos nas condutas;
- Envolver o paciente e familiares no cuidado, informando o benefício de ser inserido num protocolo gerenciado.

2. ABRANGÊNCIA/ APLICAÇÃO

Unidades de saúde hospitalares e pré-hospitalares (urgência e emergência) sob gestão CEJAM.

3. TERMINOLOGIA E CONCEITO

- **UTI:** Unidade de Terapia Intensiva
- **SV:** Sinal Vital
- **SIRS:** Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica
- **PCR:** Proteína C Reativa
- **ILAS:** Instituto Latino-Americano de Sepse
- **EPI:** Equipamento de Proteção Individual
- **SDRA:** Síndrome da Angústia Respiratória Aguda

4. PARÂMETROS E DIRETRIZES

A Sepse é definida como presença de disfunção orgânica secundária a uma agressão infecciosa. Apresenta taxas elevadas de incidência e mortalidade. O estudo SPREAD, conduzido pelo ILAS, apontou que 30% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Brasil estão ocupados por pacientes com Sepse ou Choque Séptico. A letalidade nesses pacientes foi de 55%. Assim, todos os profissionais devem ser capazes de reconhecer os sinais e sintomas de sepse e providenciar a conduta imediata para que o tratamento possa ser feito. Isso torna o desafio amplo e não apenas restrito a áreas como terapia intensiva e serviços de urgência/emergência, abrangendo de forma plena a instituição.

- ✓ **SEPSE:** Infecção suspeita ou confirmada associada à disfunção orgânica, de forma independente da presença de sinais de SIRS.
- ✓ **CHOQUE SÉPTICO:** Sepse que evoluiu com hipotensão não corrigida com reposição volêmica (PAM $\leq$ 65 mmHg), de forma independente de alterações de lactato.
- ✓ **INFECÇÃO SEM DISFUNÇÃO:** Infecção suspeita ou confirmada, sem disfunção orgânica, de forma independente da presença de sinais de SIRS.

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.001.003

- ✓ SEPSE / CHOQUE SÉPTICO EM TERMINALIDADE: Avaliar medidas de conforto e protocolo institucional.
- ✓ SIRS: Resposta inflamatória generalizada do organismo a uma infecção grave, frequentemente associada com disfunções orgânicas, hipoperfusão ou hipotensão.
- ✓ Paciente não elegível.

Todos os profissionais de saúde envolvidos diretamente no cuidado ao paciente, devem reconhecer os sinais de alerta de Seps. O padrão de atendimento para os pacientes internados e em atendimento ambulatorial com suspeita de Seps, tem como objetivo realizar a identificação precoce e dar seguimento ao protocolo.

Critérios de admissão em unidade de internação:

- Pacientes com Infecção sem disfunção orgânica;
- Pacientes com Seps que REVERTEM à disfunção orgânica após tratamento inicial em Pronto Socorro quando não houver vaga em unidade crítica e superlotação da unidade de origem.

Critérios de alta da unidade de internação (alta hospitalar):

- Melhora clínica.

Critérios de admissão em UTI:

- Pacientes com Seps que REVERTEM PARCIALMENTE à disfunção orgânica após tratamento inicial;
- Pacientes com Seps que NÃO REVERTEM à disfunção orgânica após tratamento inicial;
- Pacientes com Choque Séptico;
- Pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SARA) induzido pela Seps;

Critérios de alta da UTI:

- Melhora clínica, estabilidade hemodinâmica e respiratória, sem dependência de medidas de suporte hemodinâmico e respiratório.

A análise final compreende os indicadores:

- Taxa de Conformidade do 1º Lactato
- Taxa de aderência ao pacote de exames da 1ª hora seps

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.001.003

Pág. 4 de 19

- Taxa de Conformidade da Antibioticoterapia
- Taxa de conformidade da reposição volêmica
- Letalidade por Sepses
- Letalidade por Choque Séptico
- Estimativa de Vidas Salvas (alta de pacientes com confirmação para Sepses/Choque Séptico)

TRIAGEM E INCLUSÃO NO PROTOCOLO

I. Diagnóstico da Sepses:

Sepses deve ser suspeitada em todos os pacientes com quadro infeccioso.

A equipe multidisciplinar deve estar atenta à presença dos critérios de resposta inflamatória sistêmica, que definem a presença de infecção.

- ✓ Temperatura central $> 38,3^{\circ}\text{C}$ ou $< 36^{\circ}\text{C}$;
- ✓ Frequência cardíaca $> 90\text{ bpm}$;
- ✓ Frequência respiratória $> 20\text{ irpm}$, ou $\text{PaCO}_2 < 32\text{ mmHg}$;
- ✓ Leucócitos totais $> 12.000/\text{mm}^3$ ou $< 4.000/\text{mm}^3$ ou presença de $> 10\%$ de formas jovens.

Nos pacientes com critérios de SIRS, a presença de disfunção orgânica define o diagnóstico de sepses. As principais disfunções orgânicas são:

- ✓ Hipotensão ($\text{PAS} < 90\text{ mmHg}$ ou $\text{PAM} < 65\text{ mmHg}$ ou queda de $\text{PA} > 40\text{ mmHg}$);
- ✓ Oligúria ($\leq 0,5\text{ml/Kg/h}$);
- ✓ Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300\text{ mmHg}$;
- ✓ Contagem de plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$ ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias;
- ✓ Acidose metabólica inexplicável: déficit de bases $\leq 5,0\text{ mEq/L}$ e lactato > 2 vezes o valor normal;
- ✓ Alteração do nível de consciência;
- ✓ Aumento significativo de bilirrubinas ($> 2\text{X}$ o valor de referência).

Observação: Lembre-se: A ausência dos critérios de SIRS não exclui o diagnóstico de Sepses. Alguns pacientes, principalmente idosos e imunossuprimidos, não apresentam esses sinais. Assim, na presença de uma dessas disfunções, sem outra explicação plausível, pense em

Sepse e inicie as medidas preconizadas. Caso seja comprovado posteriormente não se tratar de Seps, sempre poderemos suspender a antibioticoterapia.

A triagem inicial será baseada nos critérios de SIRS e de disfunção orgânica. **Qualquer colaborador que identificar pelo menos 2 critérios de SIRS e/ou 1 critério de disfunção orgânica, deverá ABRIR O PROTOCOLO** e comunicar o enfermeiro do setor, que iniciará o processo acionando a equipe médica imediatamente.

O médico deverá avaliar o paciente e definir se há foco infeccioso (presumido ou confirmado). Se não houver suspeita clínica de infecção, o paciente não será incluído no protocolo.

Segundo Rhee et al, os critérios de qualidade na abordagem da seps possuem complexidades inerentes, já que os primeiros sinais da condição são muitas vezes genéricos e subjetivos, um desafio diagnóstico também presente na pneumonia, em especial durante as horas iniciais de avaliação médica. A seps se apresenta como um desafio diagnóstico ainda mais intrincado em relação à pneumonia, devido ao seu espectro diversificado de infecções e disfunções orgânicas, as quais têm numerosas condições não infecciosas como diferencial, conforme demonstrado na tabela anexada. É estimado que cerca de 40% dos pacientes inicialmente tratados para seps podem, na verdade, ter uma baixa probabilidade de infecção bacteriana quando avaliados retrospectivamente. Portanto, uma abordagem terapêutica apressada pode levar à exposição desnecessária a antibióticos, sem benefícios correspondentes.

O foco regulatório intenso em seps também pode predispor os clínicos a uma preferência prematura por diagnósticos infecciosos, possivelmente postergando o reconhecimento de patologias graves de natureza não infecciosa. Abaixo as principais causas que podem mimetizar (ou imitar) a seps e que devem ser consideradas no diagnóstico diferencial.

Tabela – Causas que podem mimetizar a seps (diagnósticos diferenciais)

Categoria	Exemplos
Doença cardíaca	Arritmias
	Insuficiência cardíaca
	Infarto do miocárdio
Doença pulmonar	Síndrome respiratória aguda grave

	Pneumonite por aspiração
	Exacerbação da asma
	Exacerbação de bronquiectasia
	Exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
	Surto de doença pulmonar intersticial
	Pneumonite de hipersensibilidade
	Embolia pulmonar

Cont.

Doença gastrointestinal	Insuficiência hepática aguda
	Obstrução intestinal
	Hemorragia gastrointestinal
	Doença inflamatória intestinal
	Isquemia mesentérica
	Pancreatite
	Vólvulo
Doença do sistema nervoso central	Disfunção autonômica
	Convulsão
	AVC/hemorragia intracraniana
Doença endócrina	Insuficiência adrenal
	Cetoacidose diabética
	Coma mixedematoso
	Tempestade tireoideana (crise tireotóxica)
Doença hematológica / oncológica	Síndrome antifosfolipídica
	Malignidade
	Síndrome hemofagocítica
	Síndrome de lise tumoral
Doença reumatológica / autoimune	Gota
	Artrite reumatoide
	Doença de Still
	Lúpus eritematoso sistêmico
	Vasculite
Drogas / toxinas	Overdose de drogas
	Abstinência de drogas/álcool
	Reação medicamentosa de hipersensibilidade
	Toxicidade medicamentosa

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.001.003

Pág. 8 de 19

	Hipertermia maligna
	Síndrome maligna neuroléptica
	Síndrome da serotonina
Outros	Rejeição de aloenxerto (receptores de transplante de órgãos sólidos)
	Anafilaxia
	Síndrome compartimental
	Insolação
	Hemorragia
	Hipovolemia
	Pós-operatório
	Queimaduras graves
	Isquemia tecidual

Fonte: Rhee, et al. Clinical Infectious Diseases, 2021.

5. ANTIBIOTICOTERAPIA RECOMENDADA

INFECÇÃO			
INFECÇÃO	ETIOLOGIA PROVÁVEL	ANTIMICROBIANOS	DURAÇÃO DA TERAPIA (DIAS)
Septicemia e Choque Séptico	Foco Pulmonar (Infecção Comunitária)	Ceftriaxone 1g EV 12/12h + Claritromicina 500mg EV 12/12h	07 dias com possibilidade de extensão do tempo. Reavaliar de acordo com perfil epidemiológico e a duração da terapia.
		DPOC: Levofloxacino 750 mg 1x ao dia	
		Pneumonia Aspirativa: Clindamicina 600mg EV 6/6h + Ceftriaxona 1g EV 12/12h OU	

		Amoxicilina + Ac. Clavulânico 500/125 mg 8/8h	
	Foco Urinário (Infecção Comunitária)	Ceftriaxone 1g EV 12/12h	07 dias com possibilidade de extensão do tempo Reavaliar de acordo com perfil epidemiológico e a duração da terapia.
	Foco Abdominal (Infecção Comunitária)	Ceftriaxona 1g EV 12/12h + Metronidazol 500mg EV 8/8h	07 dias com possibilidade de extensão do tempo Reavaliar de acordo com perfil epidemiológico e a duração da terapia.
	Foco em pele e partes moles (Infecção Comunitária)	Erisipela ou Celulite sem sinais de necrose: Oxacilina 2g EV 4/4h	07 dias com possibilidade de extensão do tempo Reavaliar de acordo com perfil epidemiológico e a duração da terapia.
		Erisipela ou Celulite com sinais de necrose: Ceftriaxona 1g EV 12/12h + Clindamicina 600mg EV 6/6h OU Amoxacilina + Ac. Clavulânico 500/125 mg 8/8h	
	Corrente sanguínea associada a cateter central (Infecção Hospitalar)	Vancomicina 30 mg/kg na dose de ataque (max 3g) seguida de 15 mg/kg 12/12h + Cefepime 2g EV 8/8h	07 dias com possibilidade de extensão do tempo Reavaliar de acordo com perfil epidemiológico e a duração da terapia.
	Sem foco definido	Comunitária: Ceftriaxone 2g EV 12/12h	07 dias com possibilidade de extensão do tempo Reavaliar de acordo com perfil epidemiológico e a

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.001.003

Pág. 10 de 19

			duração da terapia.
		Hospitalar: Vancomicina 30mg/kg na dose de ataque (max 3g) seguida de 15mg/kg 12/12h + Meropenem 2g EV 8/8h	07 dias com possibilidade de extensão do tempo Reavaliar de acordo com perfil epidemiológico e a duração da terapia.

6. INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO

INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO
Pacientes com sinais de Sepses ou Choque Séptico.	Pacientes que não apresentem Sepses ou Choque Séptico, pacientes em cuidados paliativos, portanto sem indicação de medidas agressivas para Sepses ou Choque Séptico. Idade < 14 anos.

7. RESULTADO ESPERADO

Cuidado precoce da sepse

- Iniciar terapia empírica de amplo espectro com antimicrobiano em até 1h, a partir da identificação dos sinais para pacientes com Sepses, Sepses provável e Choque Séptico.
- Iniciar ressuscitação volêmica em pacientes com sinais de hipoperfusão na primeira hora.
- Iniciar vasopressores para pacientes que não responderem à ressuscitação volêmica.
- Realizar controle de foco.

Manejo da dor, agitação e delirium

- Realizar o controle de dor conforme rotina institucional local (escalas apropriadas).
- Considerar opióides intravenosos como terapia de primeira escolha para tratamento da dor não neuropática em pacientes criticamente doentes.
- Preferir estratégias de sedação com sedativos não benzodiazepínicos (propofol ou dexmedetomidina) ao invés de benzodiazepínicos (midazolam ou lorazepam) em pacientes em ventilação mecânica.
- Utilizar escalas de sedação.

- Minimizar o uso de sedativos nos pacientes em ventilação mecânica, titulando os medicamentos diariamente visando manter o menor nível de sedação possível.
- Realizar despertar diário de acordo com a rotina local ou manter alvo de sedação leve.
- Monitorizar o delirium conforme rotina local.

Mobilização precoce e reabilitação

- Realizar mobilização precoce sempre que possível.
- Avaliar, o mais precocemente possível, os riscos do paciente desenvolver nova morbidade.
Realizar, em pacientes com risco, avaliação clínica abrangente das necessidades atuais de reabilitação. Isso deve incluir avaliação dos profissionais de saúde, com experiência em cuidados intensivos e reabilitação.
- Para pacientes em risco, começar a reabilitação logo que clinicamente possível.

8. ROTINA

Nº	ETAPAS	PARTES ENVOLVIDAS	DESCRIÇÃO
01	Identificação de Caso de Seps	Equipe Multidisciplinar	➤ Avaliar Presença de sinais e sintomas de Seps; ➤ Realizar abertura da ficha do protocolo de seps e comunicar o enfermeiro da unidade.
02	Avaliação/Classificação /Tomada de conduta	Enfermeiro (Técnico / Auxiliar de Enfermagem)	➤ Priorizar os atendimentos dos usuários suspeitos de seps; ▢ Chamar usuário pelo nome completo e confirmar identificação com a data de nascimento; ➤ Verificar sinais vitais; ➤ Hipotermia (temperatura axilar abaixo de 36°C); ➤ Hipertermia (temperatura axilar acima de 38°C); ➤ Taquipneia (frequência respiratória acima de 20 RPM); ➤ Taquicardia (frequência cardíaca superior a 90 BPM); ➤ Oligúria (débito urinário menor do que 0,5ml/kg/h); ➤ Hipotensão (pressão sistólica < 90 mmHg ou pressão arterial média < 65 mmHg); ➤ Alteração do nível de consciência ou confusão mental;

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.001.003

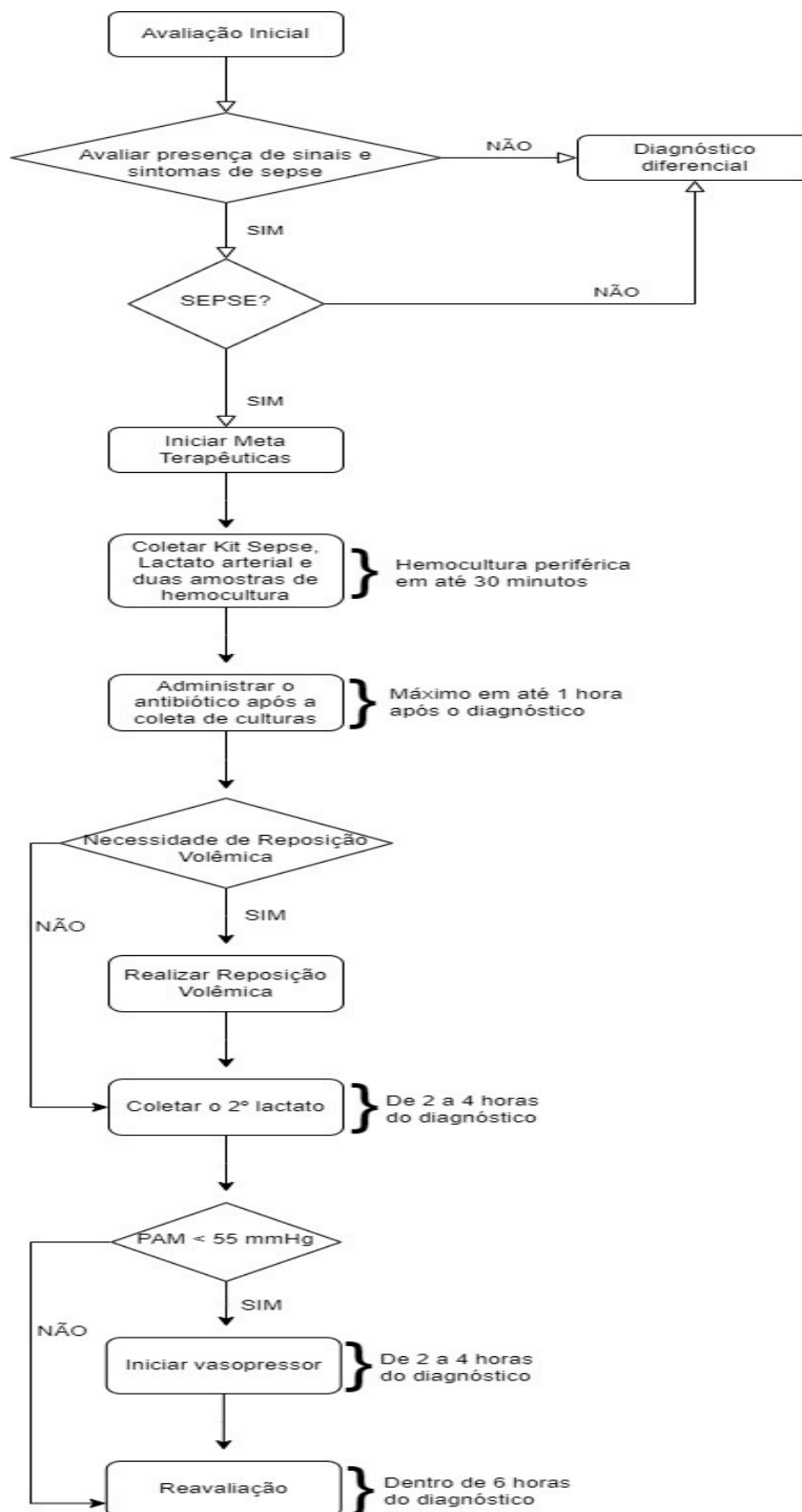
Pág. 13 de 19

			➤ Hiperglicemia (maior do que 190 mg/dl); ➤ Classificar o risco, que deverá ser de cor no mínimo amarela (HumanizaSUS) ou laranja (Manchester); ➤ Preencher a ficha de gerenciamento do protocolo sepse e após arquivar conforme rotina institucional; ➤ Comunicar o médico de plantão e solicitar a presença para atendimento (de acordo com a classificação a partir da cor amarela (HumanizaSUS) ou laranja (Manchester); ➤ Realizar Monitorização cardíaca; ➤ Puncionar acesso venoso periférico calibroso; ➤ Iniciar soroterapia conforme prescrição médica, o protocolo sugere Ringer lactato; ➤ Providenciar kit sepse – seguir rotina institucional ➤ Iniciar antibioticoterapia empírica precoce (somente após avaliação médica); ➤ Se confirmado sepse pelo médico, manter o usuário em repouso absoluto no leito em sala de emergência, com cabeceira elevada de 30º a 45º; ➤ Administrar medicação de acordo com prescrição médica; ➤ Caso não confirmado, o impresso deverá ser arquivado anexado com a ficha de atendimento /prontuário, o usuário seguirá para
--	--	--	--

			atendimento conforme classificação; ➤ Registrar atendimento em prontuário; ➤ Avaliar junto a equipe médica a transferência para unidade de suporte avançado (UTI/ Sala de Emergência); ➤ Inserir paciente na central de regulação de vagas caso a unidade não possua UTI.
03	Avaliação/Classificação /Tomada de conduta	Médico	➤ Chamar usuário pelo nome completo e confirmar identificação com a data de nascimento; ➤ Realizar avaliação, investigando sinais e sintomas sugestivos de Sepsis de acordo com formulário específico; ➤ Se suspeita de Sepsis prescrever coleta de kit sepsis e antimicrobiano indicado; ➤ Inserir paciente na central de regulação de vagas (NIR) caso a unidade não possua UTI; ➤ Acompanhar o usuário durante a transferência até o local apropriado de internação de acordo com a gravidade do caso; ➤ Realizar reavaliação do paciente; ➤ Preencher ficha de gerenciamento do protocolo de sepsis; ➤ Encaminhar a ficha preenchida conforme rotina local; ➤ Registrar atendimento em prontuário.

04	Análise do Processo	Gestor do Protocolo na Unidade e Time de Sepse	➤ Monitorar todos os casos de Sepse do Serviço; ➤ Inserir os dados do protocolo no "forms" institucional de gerenciamento; ➤ Avaliar os desfechos; ➤ Mensurar mensalmente os indicadores de sepse do serviço, realizar a análise crítica e propor ações de melhorias.
05	Análise Crítica dos Dados	Gestor CEGISS do Protocolo	➤ Avaliar mensalmente a performance dos indicadores de sepse das unidades Hospitalares; ➤ Emitir relatório de monitoramento e acompanhamento dos resultados.

FLUXOGRAMA



Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.001.003

9. PONTOS CRÍTICOS E RISCOS

PARTES ENVOLVIDAS	RISCOS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Usuário	Classificação incorreta Demora no atendimento Falha de equipamento Falha técnica Escolha de Antibiótico inapropriado	Utilização de Classificação de Risco Monitoramento do tempo de entrada até o término do atendimento Teste diário e Manutenção Preventiva dos equipamentos Utilização de protocolo específico Técnica Asséptica
Ocupacional (Colaboradores)	Contaminação Ergonômico Falhas de comunicação	Uso de EPIs Educação do continuada do colaborador
Ambiental	Agressão ao Meio Ambiente por descarte não adequado	Descarte Adequado

10. DOCUMENTOS ASSOCIADOS E REFERÊNCIAS

1. FOR.AS.RAS.RAH.002.001 - INDICADORES DE QUALIDADE - SEPSE
2. INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE (ILAS). Guia prático de terapia antimicrobiana na sepse. 2. ed. São Paulo: Instituto Latino Americano de Sepse, 2022. E-book. ISBN 978-65-992258-2-6. Disponível em: https://ilas.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Guia_ATM_final.pdf. Acesso em: 07 ago 2023.
3. EVANS, L.; RHODES, A.; ALHAZZANI, W.; ANTONELLI, M.; COOPERSMITH, C. M.; FRENCH, C. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Critical Care Medicine, v. 49, n. 11, p. e1063-e1143, nov. 2021. DOI: <http://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005337>. Acesso em: 07 ago 2023.
4. COOPERSMITH, C. M.; DE BACKER, D.; DEUTSCHMAN, C. S. et al. Surviving Sepsis Campaign: Research priorities for sepsis and septic shock. Intensive Care Medicine, [S.l.], 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00134-018-5175-z>. Acesso em: 07 ago 2023.
5. RHEE, C.; CHIOTOS, K.; COSGROVE, S. E.; HEIL, E. L.; KADRI, S. S.; KALIL, A. C.; et al. for the Infectious Diseases Society of America Sepsis Task Force. Recommended Revisions to the National Severe Sepsis and Septic Shock Early Management Bundle (SEP-1) Sepsis Quality Measure. Clinical Infectious Diseases, [S.l.], v. 72, n. 4, p. 541-552, 15 fev. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa059>. Acesso em: 07 ago 2023.
6. LIMA, A. P. S. et al. Classificação de risco e tempo porta-antibiótico no paciente com suspeita de sepse. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 31, p. e4064, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6635.4066>. Acesso em: 07 ago 2023.
7. HUSABO, G.; NILSEN, R. M.; FLAATTEN, H.; SOLLIGARD, E.; FRICH, J. C.; BONDEVIK, G. T. et al. Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: an observational study. PLoS One, [S.l.], v. 15, n. 1, e0227652, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227652>. Acesso em: 07 ago 2023.
8. ALMEIDA, N. R. C.; PONTES, G. F.; JACOB, F. L.; DEPRÁ, J. V. S.; PORTO, J. P. P.; LIMA, F. R. et al. Analysis of trends in sepsis mortality in Brazil and by regions from 2010 to 2019. Rev Saude Publica, [S.l.], v. 56, n. 25, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056003789>. Acesso em: 07 ago 2023.
9. SINGER, M.; DEUTSCHMAN, C. S.; SEYMOUR, C. W. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA, v. 315, n. 8, p. 801-810, 2016. doi: <http://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>. Acesso em: 07 ago 2023
10. RHODES, A.; PHILLIPS, G.; BEALE, R. et al. The Surviving Sepsis Campaign bundles and outcome: results from the International Multicentre Prevalence Study on Sepsis (the IMPReSS study). Intensive Care Medicine, v. 41, n. 9, p. 1620-1628, 2015. doi: <http://doi.org/10.1007/s00134-015-3906-y>. Acesso em: 07 ago 2023
11.  FOR.AS.CCI.CGR.005.002 - FICHA DE GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO DE SEPSE.pdf